

DLBCL / CNSL 新治疗与机制文 献监测

近 7 天官方 PubMed 窗口：2026-06-01 至 2026-06-07。每篇文章单独成页，按“标题、结论、主要内容、关键信息、启示”快速浏览；启示严格区分已验证证据、作者观点和我的推断。

EDAT 新入库	PDAT 发表日期	MDAT 记录更新	精选入页
42	69	213	10

固定公网主页：<https://zhengyipharmacy-collab.github.io/pubmed-lymphoma-slides/>

下载 PDF 下载 PPTX

检索与筛选说明

PubMed 官方 ESearch/EFetch 于 2026-06-07 检索；窗口为 2026-06-01 至 2026-06-07，合并 EDAT、PDAT、MDAT 覆盖近 7 天新入库、发表日期和记录更新。与 2026-06-06 晚间重跑相比，今日新进入候选池的治疗相关重点为 PMID 38651796；其余正文页为仍在 7 天滚动窗口内的高相关参考。MDAT 命中的旧发表文章已逐篇标注，不等同于近 7 天新发表。

检索式：((DLBCL[Title/Abstract] OR "diffuse large B-cell lymphoma"[Title/Abstract] OR "large B-cell lymphoma"[Title/Abstract] OR LBCL[Title/Abstract] OR PCNSL[Title/Abstract] OR "primary CNS lymphoma"[Title/Abstract] OR "primary central nervous system lymphoma"[Title/Abstract] OR CNSL[Title/Abstract] OR "central nervous system lymphoma"[Title/Abstract] OR "secondary CNS lymphoma"[Title/Abstract] OR "secondary central nervous system lymphoma"[Title/Abstract]) AND lymphoma[Title/Abstract])

覆盖方向：BTKi、双抗、CAR-T/细胞治疗、ADC、免疫治疗、靶向联合、病例/病例系列、基础/机制/转化、耐药、CNS 穿透/药代、安全性和真实世界。

#	方向	疾病	PMID	标题	打开链接
1	CAR-T / 安全性与疗效关联	R/R DLBCL	38651796	CD19 CAR-T 后持续性细胞减少：R/R DLBCL 疗效与毒性信号	打开文献
2	双抗 + ADC / III 期随机临床试验	R/R LBCL	41037766	SUNMO III 期：mosunetuzumab + polatuzumab 治疗移植不适合 R/R LBCL	打开文献
3	ADC / 临床系统综述	R/R DLBCL	42244006	Loncastuximab tesirine 单药治疗 R/R DLBCL 的系统综述与 Meta 分析	打开文献
4	BTKi 联合 / I 期临床试验	R/R DLBCL	41824782	Zanubrutinib + lenalidomide 治疗 R/R DLBCL 的 I 期多中心研究	打开文献
5	免疫联合 / II 期临床试验	R/R DLBCL	41656201	R2-GemOx-PD1i 治疗 R/R DLBCL 的多中心单臂 II 期试验	打开文献
6	双抗 / 临床影像预后	R/R LBCL	42223630	CD3-CD20 双抗治疗 R/R LBCL 中 FDG-PET 动态指标的临床预后价值	打开文献
7	双抗 / 个案与局部治疗	R/R DLBCL	42236241	epcoritamab 联合局部放疗获得难治 DLBCL 长期缓解个案	打开文献
8	PCNSL / 双抗真实世界	R/R PCNSL	42035265	Glofitamab 治疗 R/R PCNSL 的多中心真实世界：疗效、CNS 穿透与 CSF ctDNA	打开文献
9	PCNSL / II 期临床试验	newly diagnosed PCNSL	41672977	Pen-RMA 治疗新诊断 PCNSL 的 II 期临床试验	打开文献
10	CAR-T / 异体现货型细胞治疗 I 期	R/R LBCL	39946666	ALPHA/ALPHA2：异体 CD19 CAR-T cema-cel / ALLO-501 治疗 R/R LBCL	打开文献

CD19 CAR-T 后持续性细胞减少：R/R DLBCL 疗效与毒性信号

Persistent Cytopenia After CD19 CAR T Therapy in Relapsed/Refractory DLBCL Patients Could Be a Predictor of Efficacy and Side Effects.

PMID 38651796

打开 PubMed 文献

CAR-T / 安全性与疗效关联	R/R DLBCL	今日新进入候选池；MDAT 命中；原始发表日期较早，不是近7天新发表	
P 接受 CD19 CAR-T 的复发/难治 DLBCL 患者	I CD19 CAR-T 治疗及输注后持续性细胞减少监测	C 发生 3-4 级持续性细胞减少 vs 未发生持续性细胞减少	O ORR、PFS、OS、IL-6/CAR-T 峰值、CRS、血细胞恢复和不良事件

结论

38 例 R/R DLBCL 的 CD19 CAR-T 研究显示，3-4 级持续性细胞减少与较高肿瘤负荷、IL-6/CAR-T 峰值、CRS 等相关，并可能同时提示疗效和不良事件风险。

主要内容

- 研究纳入 38 例 R/R DLBCL，CAR-T 前接受 fludarabine/cyclophosphamide 淋巴清除。
- 14 例发生 3-4 级持续性细胞减少，恢复时间为 CAR-T 输注后 8-18 周。
- 发生持续性细胞减少者均达到客观缓解；在缓解患者中，高肿瘤负荷者更常见 3-4 级持续性细胞减少。
- 持续性细胞减少组 IL-6 峰值、CAR-T 细胞峰值和 CRS 级别更高，PFS/OS 也高于无细胞减少组。

关键信息

- 这是今日相对昨晚新进入候选池中治疗相关性最强的一篇。
- 细胞减少既可能是毒性管理问题，也可能反映 CAR-T 扩增、炎症和抗肿瘤活性。
- 样本量小，结论需要更大队列验证，不能把持续性细胞减少简单解释为有利事件。

启示

已验证证据 PubMed 摘要确认研究人群、CAR-T 方案、持续性细胞减少发生比例、恢复时间、IL-6/CAR-T 峰值、CRS 和生存关联。	论文作者观点 作者认为，CAR-T 后持续性细胞减少可能帮助判断 CD19 CAR-T 疗效和相关不良事件。	我的推断 后续 CAR-T 方案设计可把血细胞恢复曲线、肿瘤负荷、IL-6、CAR-T 扩增峰值和 CRS 作为联合监测变量；这不是治疗推荐。
--	--	---

SUNMO III 期：mosunetuzumab + polatuzumab 治疗移植不适合 R/R LBCL

PMID 41037766

打开 PubMed 文献

Mosunetuzumab Plus Polatuzumab Vedotin in Transplant-Ineligible Refractory/Relapsed Large B-Cell Lymphoma: Primary Results of the Phase III SUNMO Trial.

双抗 + ADC / III 期随机临床试验 R/R LBCL MDAT 近7天窗口命中：昨晚已纳入，今日继续作为滚动高相关参考；不是近7天新发表

P 不适合自体移植或治愈意图治疗的 R/R LBCL 患者

I Mosunetuzumab + polatuzumab vedotin 固定疗程联合方案

C Rituximab + gemcitabine + oxaliplatin

O ORR、CR、PFS、OS、安全性、CRS 和患者报告结局

结论

SUNMO III 期显示，mosunetuzumab + polatuzumab 较 R-GemOx 显著提高 ORR 和 PFS，且 CRS 事件较少，提示固定疗程门诊方案在移植不适合 R/R LBCL 中具有重要临床信号。

主要内容

- 208 例移植不适合 R/R LBCL 按 2:1 随机接受 Mosun-Pola 或 R-GemOx。
- 中位随访 23.2 个月；中位 PFS 为 11.5 个月 vs 3.8 个月，HR 0.41，P < 0.0001。
- ORR 为 70% vs 40%，CR 为 51% vs 24%。
- Mosun-Pola 组 2 级及以上 CRS 和托珠单抗使用均低于 5%，患者报告结局较 R-GemOx 改善。

关键信息

- 这是双抗和 ADC 联合的 III 期随机证据，临床优先级高。
- 比较对象是 R-GemOx，便于放入移植不适合 R/R LBCL 的现实路径中解读。
- 需要继续关注 OS、后续治疗序贯、感染和神经毒性等完整安全性信息。

启示

已验证证据

PubMed 摘要确认研究设计、样本量、PFS、ORR/CR、CRS 和患者报告结局数据。

论文作者观点

作者认为 Mosun-Pola 较 R-GemOx 显示更优疗效，且 CRS 少、安全性可管理。

我的推断

后续方案设计可把“固定疗程、门诊可实施、双抗+ADC 序贯位置”作为核心变量；这不是治疗推荐。

Loncastuximab tesirine 单药治疗 R/R DLBCL 的系统综述与 Meta 分析

PMID 42244006

打开 PubMed 文献

Efficacy and safety of loncastuximab tesirine in relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma: a systematic review and meta-analysis.

ADC / 临床系统综述

R/R DLBCL

EDAT/PDAT/MDAT 近7天窗口命中; 2026-06-05 PubMed 入库; ADC 临床证据汇总

P 复发/难治 DLBCL, 尤其是移植或 CAR-T 不适合/选择有限患者

I Loncastuximab tesirine 单药

C 不同临床试验和观察队列的合并分析

O ORR、CR、OS、PFS、治疗相关不良事件

结论

7 项临床研究汇总显示, loncastuximab tesirine 单药在重度经治 R/R DLBCL 中 ORR 约 47%、CR 约 22%, 但 3 级及以上不良事件负担较高。

主要内容

- 纳入 3 项临床试验和 4 项观察队列, 均报告 loncastuximab tesirine 单药临床结局。
- 合并 ORR 为 47.3%, CR 为 22.0%; 1 年 OS 为 48.2%, 1 年 PFS 为 31.2%。
- 临床试验亚组 ORR 47.3%, CR 23.9%, 1 年 OS 43.8%, 1 年 PFS 28.0%。
- 任意治疗相关不良事件发生率 98.7%, 3 级及以上事件 82.6%。

关键信息

- ADC 方向的临床证据汇总, 直接符合“临床研究”筛选标准。
- 疗效信号需和高等级毒性、患者选择、序贯治疗一起评估。
- 作者强调需要随机研究进一步优化患者选择和排序。

启示

已验证证据

摘要确认纳入研究类型、ORR/CR/OS/PFS 和高等级不良事件比例。

论文作者观点

作者认为该药在选择有限的 R/R DLBCL 中有临床价值, 但仍需随机研究优化选择和排序。

我的推断

后续临床研究应预设 CAR-T/双抗暴露史、骨髓储备、既往感染和水肿/皮疹管理变量; 这不是治疗推荐。

Zanubrutinib + lenalidomide 治疗 R/R DLBCL 的 I 期多中心研究

PMID 41824782

打开 PubMed 文献

Phase 1 study of zanubrutinib plus lenalidomide for patients with relapsed/refractory diffuse large B-cell lymphoma.

BTKi 联合 / I 期临床试验

R/R DLBCL

MDAT 近7天窗口命中: BTKi 联合临床研究; 原始在线早于本周

P

复发/难治 DLBCL 患者

I

Zanubrutinib 160 mg bid + lenalidomide 15/20/25 mg qd

C

不同 lenalidomide 剂量层级和历史预期

O

RP2D、ORR、CR、DOR、PFS、TEAE

结论

66 例 R/R DLBCL I 期研究显示, zanubrutinib 160 mg bid + lenalidomide 25 mg qd 为推荐 II 期剂量; RP2D 下 ORR 58%、CR 42%, 但 3 级及以上 TEAE 为 74%。

主要内容

- BGB-3111-110 为多中心 dose-escalation/expansion I 期研究。
- 患者中位既往治疗 2 线, 83% 为 III/IV 期, 约 67% 为 non-GCB 或 ABC-like。
- 无剂量限制性毒性; lenalidomide RP2D 为 25 mg qd。
- RP2D 下中位 DOR 14.9 个月, 中位 PFS 5.5 个月; 常见 3 级及以上 TEAE 为中性粒和白细胞减少。

关键信息

- 明确临床试验, 符合用户“临床研究”要求。
- BTKi 联合免疫调节剂仍有 R/R DLBCL 探索价值。
- 疗效信号必须和骨髓抑制、停药和死亡事件一起看。

启示

已验证证据

摘要确认 66 例、RP2D、ORR/CR、PFS/DOR 和 3 级及以上 TEAE。

论文作者观点

作者认为该联合在 R/R DLBCL 中显示可接受耐受性和抗肿瘤活性。

我的推断

后续临床试验应重点分层 non-GCB/ABC-like、既往治疗线数、骨髓储备和感染风险。

R2-GemOx-PD1i 治疗 R/R DLBCL 的多中心单臂 II 期试验

Penpulimab in combination with lenalidomide and R-GemOx regimen (R2-GemOx-PD1i) in relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma: a multicenter, single-arm, phase 2 trial.

PMID 41656201

打开 PubMed 文献

免疫联合 / II 期临床试验

R/R DLBCL

MDAT 近7天窗口命中：PD-1 联合 R/R DLBCL 方案；原始发表早于本周

P

R/R DLBCL 患者

I

Penpulimab + lenalidomide + R-GemOx，随后维持或 ASCT

C

非 ASCT 意向组与 ASCT 桥接组

O

CRR、ORR、PFS、OS、安全性、免疫相关不良事件

结论

54 例 R/R DLBCL II 期研究中，penpulimab + lenalidomide + R-GemOx 诱导后 ORR 66.7%、CRR 57.4%，中位 PFS 30.4 个月。

主要内容

- 患者接受最多 6 个周期 R2-GemOx-PD1i，每 2 周一次。
- 38 例无 ASCT 意向，16 例作为 ASCT 桥接。
- 无 ASCT 意向组 ORR 63.2%、CRR 52.6%，中位 PFS 21.2 个月。
- ASCT 桥接组 ORR 75.0%、CRR 68.8%；常见 TRAE 为中性粒减少、贫血，常见免疫相关事件为甲状腺功能减退。

关键信息

- 明确临床 II 期试验，属于用户要求的临床证据。
- 同时提供非 ASCT 意向与 ASCT 桥接两个临床路径亚组。
- 需要随机对照或更大样本确认。

启示

已验证证据

摘要确认样本量、治疗方案、ORR/CRR、PFS 和主要安全性事件。

论文作者观点

作者认为 R2-GemOx-PD1i 显示鼓舞性抗肿瘤活性和可管理毒性。

我的推断

R/R DLBCL 临床研究应区分“桥接至 ASCT”与“非巩固意向”两类目标路径，而不是混合评价。

CD3-CD20 双抗治疗 R/R LBCL 中 FDG-PET 动态指标的临床预后价值

PMID 42223630

打开 PubMed 文献

Prognostic role of FDG-PET in patients with relapsed/refractory large B-cell lymphoma treated with CD3-CD20 directed bispecific antibodies: a multicentric analysis.

双抗 / 临床影像预后 R/R LBCL EDAT/PDAT/MDAT 近7天窗口命中; 双抗治疗后 PET 风险分层; 2026-06-01 PubMed 入库

P 接受 CD3-CD20 双抗治疗的 R/R LBCL 患者

I 基线与治疗后 FDG-PET 半定量动态评估

C 不同 MTV、Deauville score、SUVmean 降幅人群

O PFS、OS、进展风险和风险分层能力

结论

58 例接受 CD3-CD20 双抗的 R/R LBCL 多中心分析显示，基线 MTV、首次随访 Deauville score 和 SUVmean 降幅可识别高进展风险患者。

主要内容

- 纳入 58 例有基线 PET 的 R/R LBCL，其中 45 例有双抗启动后首次 PET。
- 基线 whole-body MTV > 504.7 cm3 与更短 PFS 相关。
- 首次随访 DS4-5 与更高进展风险和较短生存相关。
- 未达到 SUVmean 下降 75.5% 与 PFS 和 OS 事件风险增加相关。

关键信息

- 这是双抗治疗中的临床影像预后研究，不是基础机制研究。
- 有助于把双抗疗效监测从 ORR/CR 扩展到早期动态风险分层。
- 样本量有限，但指标具备临床流程可操作性。

启示

已验证证据

摘要确认 58 例多中心队列、PET 参数和 PFS/OS 关联。

论文作者观点

作者认为纵向半定量 PET 可增强双抗治疗人群风险分层和个体化管理。

我的推断

双抗临床研究应预设基线 MTV、早期 Deauville score 和 SUVmean 降幅，作为换策略或联合研究的探索性指标。

epcoritamab 联合局部放疗获得难治 DLBCL 长期缓解个案

[Long-term remission in refractory diffuse large B-cell lymphoma with concurrent epcoritamab and radiotherapy].

PMID 42236241

打开 PubMed 文献

双抗 / 个案与局部治疗

R/R DLBCL

EDAT/MDAT 近7天窗口命中：双抗联合放疗个案；证据级别为病例报告



87 岁难治 DLBCL 个案，epcoritamab 后局部残留病灶



继续 epcoritamab 同时加用局部放疗



个案内治疗前后影像变化；无独立对照



完全代谢缓解、持续缓解周期和不良事件

结论

一例 87 岁难治 DLBCL 在 epcoritamab 治疗中对局部残留病灶加用放疗后获得完全代谢缓解，并持续超过 27 个治疗周期。

主要内容

- 患者第三线 epcoritamab 第 5 周期后仍有脾脏和纵隔 FDG 高代谢病灶。
- 在继续 epcoritamab 同时，对两个部位给予 36 Gy/18 次 VMAT。
- 联合治疗后达到完全代谢缓解，未见显著不良事件。
- 作者认为局部放疗可能作为双抗治疗中的互补策略。

关键信息

- 单病例，证据等级低，但对“免疫治疗中局部残留病灶”很有启发。
- 覆盖高龄、重度预处理和局部难治场景。
- 不能外推为常规治疗路径。

启示

已验证证据

摘要确认个案、放疗剂量、持续 epcoritamab 和完全代谢缓解。

论文作者观点

作者认为放疗与系统治疗无交叉耐药，可能补充双抗治疗。

我的推断

未来可设计小队列探索双抗中局部进展/残留病灶的放疗时机；单例不能支持治疗推荐。

Glofitamab 治疗 R/R PCNSL 的多中心真实世界：疗效、CNS 穿透与 CSF ctDNA

PMID 42035265

打开 PubMed 文献

Multicenter Real-World Analysis of Glofitamab in Relapsed/Refractory Primary CNS Lymphoma: Clinical Activity, CNS Penetration, and ctDNA Dynamics.

PCNSL / 双抗真实世界		R/R PCNSL	MDAT 近7天窗口命中；PCNSL 双抗真实世界、CNS 穿透和 CSF ctDNA 监测					
P	成人 R/R PCNSL 患者		I	Glofitamab 单药，部分作为 CAR-T/ASCT 桥接	C	治疗前后影像、CSF 药物浓度和 ctDNA 动态	O	ORR、CR、PFS、OS、CNS 穿透、CSF ctDNA、神经毒性

结论

16 例 R/R PCNSL 多中心真实世界研究显示，glofitamab 单药 interim ORR 75%、CR 50%，可在部分患者 CSF 中检测到药物，并可用 CSF ctDNA 动态辅助监测。

主要内容

- 纳入 16 名成人 R/R PCNSL，接受 glofitamab 单药。
- 分析配对血浆和 CSF 评估 CNS drug penetration，并进行序贯 CSF ctDNA profiling。
- 中位 PFS 15.4 个月，OS 未达到；部分患者用作 CAR-T 或 ASCT 桥接。
- glofitamab 在 60% 患者 CSF 中可检测到；2 例发生 3 级及以上神经毒性并经激素恢复。

关键信息

- CNSL 双抗方向的临床真实世界证据。
- 同时提供疗效、CNS 穿透和 CSF ctDNA 动态信息。
- 样本量小，且后续 CAR-T/ASCT 可能影响长期结局。

启示

已验证证据

摘要确认样本量、ORR/CR、PFS、CSF 检出率、ctDNA 动态和神经毒性。

论文作者观点

作者认为 glofitamab 在 R/R PCNSL 中显示早期临床活性和可测 CNS 穿透，需前瞻验证。

我的推断

CNSL 临床研究应同步记录 CSF 药物浓度、CSF ctDNA、影像反应和桥接/巩固治疗路径。

Pen-RMA 治疗新诊断 PCNSL 的 II 期临床试验

Penpulimab combined with rituximab, high-dose methotrexate, and cytarabine (Pen-RMA) in newly diagnosed primary central nervous system lymphoma (PCNSL): a phase 2 trial.

PMID 41672977

打开 PubMed 文献

PCNSL / II 期临床试验 newly diagnosed PCNSL MDA 近7天窗口命中；新诊断 PCNSL PD-1 联合方案；原始发表早于本周

P 新诊断 PCNSL 患者

I Penpulimab + rituximab + HD-MTX + cytarabine 诱导，随后按年龄/反应巩固或维持

C 不同巩固路径和历史 PCNSL 治疗背景

O ORR、CR、2 年 PFS/OS、TRAE、CSF ctDNA

结论

NCT05347641 评估 penpulimab + rituximab + HD-MTX + cytarabine，新诊断 PCNSL 中诱导后 ORR 95.7%、CR 91.3%，2 年 PFS 70.7%、OS 75.0%。

主要内容

- 患者接受 6 个周期 Pen-RMA，每 3 周一次。
- 26 例入组，23 例进入 ITT 分析，中位年龄 65 岁。
- 年轻且达到至少 PR 的患者接受 ASCT 后 penpulimab 维持；年长或不适合 ASCT 者按反应接受维持或 WBRT 联合维持。
- 3 级及以上治疗相关不良事件发生于 7/23 例；13 例影像 CR 和 1 例 PR 患者进行 CSF ctDNA 监测。

关键信息

- 明确临床 II 期试验，适合替代基础研究内容。
- PCNSL 方向同时涉及 PD-1、HD-MTX、ASCT/WBRT 和维持治疗路径。
- 样本量小，需进一步验证和长期随访。

启示

已验证证据

摘要确认试验号、治疗方案、样本量、ORR/CR、2 年 PFS/OS 和安全性。

论文作者观点

作者认为 Pen-RMA 在 PCNSL 中显示鼓舞性抗肿瘤活性和可管理毒性。

我的推断

PCNSL 方案设计可把免疫治疗、巩固策略和 CSF ctDNA 动态整合到同一临床路径评估中。

ALPHA/ALPHA2：异体 CD19 CAR-T cema-cel / ALLO-501 治疗 R/R LBCL

PMID 39946666

打开 PubMed 文献

Allogeneic Chimeric Antigen Receptor T-Cell Products Cemacabtagene Ansegedleucel/ALLO-501 in Relapsed/Refractory Large B-Cell Lymphoma: Phase I Experience From the ALPHA2/ALPHA Clinical Studies.

CAR-T / 异体现货型细胞治疗 I 期 R/R LBCL MDAT 近7天窗口命中；异体 CD19 CAR-T I 期；原始发表早于本周

P CD19 CAR-T 初治的 R/R LBCL 患者

I 健康供者来源异体 CD19 CAR-T cema-cel / ALLO-501

C I 期剂量/产品经验；非随机对照

O ORR、CR、DOR、CAR-T 扩增/持久性、GVHD、CRS、ICANS、血液学毒性

结论

I 期 ALPHA2/ALPHA 经验显示，异体 CD19 CAR-T 在 CD19 CAR-T 初治 R/R LBCL 中达到 ORR 58%、CR 42%，且未报告 GVHD、ICANS 或 3 级及以上 CRS。

主要内容

- 33 例 CD19 CAR-T 初治 R/R LBCL 接受供者来源、HLA 不匹配的 cema-cel/ALLO-501。
- 淋巴清除方案包括 fludarabine、cyclophosphamide 和抗 CD52 抗体 ALLO-647。
- 可观察到 CAR-T 扩增，部分患者持久性可达 4 个月。
- CR 患者中位 DOR 为 23.1 个月；最常见 TEAE 为血液学毒性。

关键信息

- 异体现货型 CAR-T 直接回应可及性和等待时间问题。
- 样本量小、I 期性质明确，不能与已上市自体 CAR-T 直接作疗效替代判断。
- GVHD、ICANS 和高级别 CRS 未见报告，是值得后续验证的安全性信号。

启示

已验证证据

PubMed 摘要确认样本量、治疗构成、ORR/CR、DOR、安全性和未见 GVHD/ICANS/高级别 CRS。

论文作者观点

作者认为异体 CD19 CAR-T 显示有希望的总体反应和持久 CR，并支持继续评估 cema-cel。

我的推断

未来 LBCL 细胞治疗研究应把制造等待时间、桥接治疗、供者来源免疫风险和可及性作为固定字段；这不是治疗推荐。

今天的信号不是单一药物热点，而是“疗效前移 + 治疗可及 + CNS/微环境分层 + 安全管理”同步推进

已验证证据 本轮 PubMed 官方窗口命中 EDAT 42、PDAT 69、MDAT 213，去重候选 226 条；最终入页 10 篇。相对昨晚重跑，今日新进入候选池 4 条，其中治疗相关性最强的是 PMID 38651796。	论文作者观点 入页研究作者的共同观点是：R/R LBCL 和 PCNSL 证据正在从单一疗效读数扩展到固定疗程联合、CNS/CSF 监测、细胞治疗可及性、局部治疗协同和安全性动态管理。	我的推断 我的推断是，后续日报应继续把治疗线数、CAR-T/移植适合性、桥接或巩固策略、CNS 穿透/CSF ctDNA、PET/MTV、血液学毒性和免疫相关毒性作为固定观察字段；这些仅用于研究设计启示，不构成医疗建议。
下一次优先跟进 继续观察 frontMIND OS/ctDNA、PCNSL 双抗 CNS 穿透验证、双抗治疗中 PET 动态指标、CAR-T 可及性和桥接前 MTV 变化。	设计启示 DLBCL/CNSL 研究应同时记录疗效、到达治疗的路径、CNS/CSF 指标、影像负荷、分子/微环境分层和感染/神经毒性安全窗口。	边界提醒 本页仅作文献监测、证据摘要和方案设计启示整理，不提供医疗建议，也不生成治疗推荐。